

FACHKLINIK PRINZREGENT LUITPOLD · SCHEIDEGG

Pädagogisches Konzept

Tagesbetreuung in der Kinderrehabilitation

Single Source of Truth für das Erzieher-Team

Onboarding · Schulung · Knowledge Base · QM

Träger: Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. (KJF)

Oberschwenden 1 · 88175 Scheidegg / Allgäu

Version 1.0 · Stand Mai 2026 · **Vertraulich · Nur für interne Verwendung**

1. Präambel und Geltungsbereich

Dieses Konzept beschreibt die pädagogische Arbeit im Bereich der Tagesbetreuung von Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren, die mit einem Elternteil zu einer vierwöchigen stationären Rehabilitation in unsere Klinik kommen. Es ist das verbindliche Fundament für die Haltung, die methodische Arbeit, die Schutzaufträge und die täglichen Handlungsroutinen aller Erzieherinnen und Erzieher des Bereichs.

Es richtet sich ausschließlich an Mitarbeitende. Es ist gleichzeitig Orientierung für neu eingearbeitete Kolleginnen und Kollegen, Nachschlagewerk für erfahrene Teammitglieder, Schulungsunterlage und auditierbarer Bestandteil des Qualitätsmanagements nach ISO 9001 und QMS-Reha (BAR).

Das Konzept ist mit dem interaktiven internen Wissens-Hub verzahnt. Beide Dokumente sind die Single Source of Truth für die pädagogische Tagesbetreuung. Bei inhaltlichem Widerspruch gilt jeweils die aktuellere Version. Reviewzyklus: jährlich oder anlassbezogen.

Geltungsbereich

Alle Erzieherinnen und Erzieher der Tagesbetreuung Kinderreha.

Praktikantinnen, FSJ-Kräfte, Vertretungen, Honorarkräfte mit Kinderkontakt.

Anwendbar auf alle Kinder von 5 bis 12 Jahren, die mit Begleitperson aufgenommen werden.

Schwerpunkt: psychische und psychosomatische Indikationen (ADHS/ADS, Ängste, Schulabsentismus, depressive Episoden, somatoforme Störungen, Mutismus, ASS-Verdacht).

2. Vision, Mission und Werte

2.1 Vision — wohin wir wollen

Jedes Kind, das unser Haus verlässt, soll mit einem stärkeren Bild von sich selbst gehen, als es gekommen ist.

Wir wollen, dass Kinder in unserer Tagesbetreuung erleben: Hier bin ich gesehen, hier bin ich sicher, hier darf ich wachsen. Wir wollen Eltern erleben lassen, dass professionelle Pädagogik und Herzenswärme keine Gegensätze sind. Wir wollen ein Team sein, in dem Kollegialität, fachliche Tiefe und christliche Wertebindung selbstverständlich zusammengehören.

2.2 Mission — was wir täglich tun

Wir begleiten Kinder durch ihren Reha-Alltag. Wir sind verlässliche, wohlwollende Erwachsene, die zuhören, anleiten, strukturieren, mitlachen und im Notfall sicher führen. Wir ergänzen die medizinische, psychologische und schulische Behandlung um den Raum, in dem das Gelernte alltagstauglich wird. Wir entlasten Begleitpersonen und stärken das Kind in seiner Selbstwirksamkeit.

2.3 Werte — was uns trägt

Unser Träger, die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg, gründet seine Arbeit auf dem christlichen Menschenbild. Daraus ergeben sich für uns vier Leitwerte. Diese sind keine Plakate, sondern beobachtbare Verhaltensanker im Alltag.

Würde — „Du bist wertvoll, so wie Du bist.“

- Wir sprechen jedes Kind mit Namen an, ohne Verniedlichung.
- Wir kritisieren das Verhalten, nicht die Person.
- Wir gehen niemals abwertend, ironisch-spöttisch oder beschämend mit Kindern um — auch nicht im Scherz, auch nicht unter Druck.

Nächstenliebe — „Ich bin für Dich da.“

- Wir grüßen jedes Kind morgens persönlich und namentlich.
- Wir achten auf das Kind, das gerade leiser geworden ist.
- Wir nehmen Sorgen ernst, auch wenn sie aus unserer Perspektive klein wirken.

Schöpfungsverantwortung — „Wir gehen sorgsam um.“

- Mit Material, mit Räumen, mit Zeit, mit der Natur rund um die Klinik.
- Mit unseren eigenen Kräften — Selbstfürsorge ist Teil der Berufsethik.

Hoffnung — „Es geht weiter, und es kann gut werden.“

- Wir kommunizieren ressourcen- und lösungsorientiert.
- Wir vermitteln Kindern, dass schwierige Phasen vorübergehen und sie nicht definieren.

Christliche Werteorientierung — wie wir sie leben

Wir sind ein katholischer Träger. Religion ist eingeladen, nicht verordnet.

Tischgebete, Klinikseelsorge und religiöse Bräuche sind selbstverständlich präsent, aber nie aufgedrängt.

Kinder und Familien anderer oder keiner Religion sind mit derselben Würde willkommen.

Unsere Werte werden über Verhalten sichtbar, nicht über Verkündigung.

3. Pädagogische Haltung

Haltung kommt vor Methode. Eine Methode, die ohne tragfähige Haltung angewendet wird, bleibt Technik und wirkt nicht nachhaltig. Die folgenden Haltungsanker sind für alle Mitarbeitenden des Bereichs verbindlich.

3.1 Beziehung vor Erziehung

Kinder lernen über Beziehung, nicht über Belehrung. Erst wenn ein Kind sich sicher fühlt, kann es sich auf Neues einlassen. In den ersten 48 Stunden investieren wir daher bewusst mehr in Beziehungsaufbau als in Regelvermittlung.

3.2 Trauma-informierte Grundhaltung

Viele unserer Kinder bringen belastende Erfahrungen mit. Wir handeln immer nach dem Grundsatz: „Was ist Dir passiert?“ statt „Was stimmt nicht mit Dir?“.

- Verhaltensauffälligkeit ist meist Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses oder einer überlasteten Selbstregulation.
- Wir vermeiden Trigger, wo wir sie kennen: laute, plötzliche Ansprachen; körperliches Festhalten ohne Notwendigkeit; Beschämung vor der Gruppe.
- Wir bieten Vorhersehbarkeit: klare Tagesstruktur, Übergänge ankündigen, Rituale wahren.

3.3 Co-Regulation vor Verhaltenskontrolle

Kinder dieser Altersgruppe sind in akuter Belastung nicht zur Selbstregulation fähig. Sie regulieren über uns. Unsere ruhige Atmung, unsere abgesenkte Stimme, unser entspannter Körper sind die wirksamsten pädagogischen Werkzeuge in der Eskalation. Konsequenzen werden nicht in der Krise, sondern danach in Ruhe besprochen.

3.4 Ressourcenorientierung

Wir fragen nicht zuerst, was ein Kind nicht kann, sondern was es kann. Wir benennen Gelungenes konkret und zeitnah. „Du hast gerade zwei Minuten gewartet, bis Du dran warst — das ist Dir vor einer Woche noch schwerer gefallen.“ wirkt stärker als ein abstraktes „Super!“.

3.5 Partizipation

Kinder haben ein Recht auf Beteiligung an Entscheidungen, die sie betreffen (UN-Kinderrechtskonvention Art. 12). Wir holen Meinungen ein, geben echte Wahlmöglichkeiten (auch wenn es nur zwei Optionen sind), und nehmen Beschwerden ernst. Eine niedrigschwellige Beschwerdebox ist im Gruppenraum sichtbar.

4. Methodischer Rahmen — Marte Meo

Marte Meo ist unsere methodische Leitlinie für die Beziehungsgestaltung im Alltag. Sie wurde von Maria Aarts in den Niederlanden entwickelt und gehört international zu den am besten evaluierten Methoden videogestützter Entwicklungsbegleitung. Marte Meo bedeutet sinngemäß „aus eigener Kraft“.

4.1 Die Marte-Meo-Grundhaltung

- Entwicklung gelingt über gelingende Momente. Wir filmen — gedanklich oder real — Augenblicke, in denen ein Kind erfolgreich ist, und bauen darauf auf.
- Initiative des Kindes wahrnehmen und beantworten ist wichtiger als Initiative ergreifen.
- Sprache folgt dem Tun: Wir benennen, was wir sehen, statt zu kommentieren oder zu bewerten.

4.2 Die sechs Basis-Elemente nach Maria Aarts

1. Initiativen wahrnehmen

Welche Initiative geht gerade vom Kind aus? Worauf richtet sich seine Aufmerksamkeit? Wir halten kurz inne, bevor wir reagieren.

2. Initiativen bestätigen

Wir geben ein Zeichen — Blickkontakt, Nicken, ein „Hm“ — dass wir das Kind wahrgenommen haben. Das ist die einfachste, wirksamste Beziehungshandlung.

3. Benennen — sich selbst und das Kind

Wir sprechen aus, was wir tun (z. B. „Ich räume gerade die Stifte ein.“) und was das Kind tut („Du baust gerade einen Turm aus den blauen Steinen.“). Das gibt dem Kind Sprache für seine eigene Welt.

4. Bestätigen und ergänzen

Wir bauen kurz auf der Initiative des Kindes auf, statt sie zu ersetzen. Aus „Schau, ein Käfer.“ wird nicht „Ja, hier kommt jetzt das Mittagessen.“, sondern „Ja, ein schwarzer Käfer. Er läuft langsam.“.

5. Triangulieren

Wir verbinden Kinder miteinander: „Lukas, schau, was Mara gerade gebaut hat. Mara, möchtest Du Lukas zeigen, wie das geht?“.

6. Anfang, Mitte und Ende markieren

Jede Aktion bekommt einen klaren Rahmen: Anfang ansagen, mittendrin orientieren, Schluss würdigen. Das gibt Sicherheit und reduziert Übergangsstress.

4.3 Marte Meo im Gruppenalltag

Im Erzieher-Alltag wenden wir die Methode niedrigschwellig an: in der Morgenrunde, bei der Materialausgabe, beim Konflikt, beim Abschied vor der Therapie. Wer eine Marte-Meo-

Fachausbildung anstrebt, kann sich über die Bereichsleitung informieren. Externe Video-Supervision findet ein- bis zweimal jährlich statt.

Marte-Meo-Reminder für den Alltag

Atme kurz, bevor Du reagierst.

Sieh hin, dann sag etwas.

Sag, was Du siehst — nicht, was fehlt.

Markiere Anfang und Ende jeder Aktivität.

5. Strategien im Umgang mit den häufigsten Diagnosen

Die folgenden Karten sind Handlungsleitfäden, keine Diagnosen. Diagnostik und Therapie bleiben bei den Fachärzten und Psychologen. Unsere Aufgabe ist es, im Alltag förderlich, sicher und konsistent zu handeln. Bei Unsicherheit gilt immer: lieber einmal zu viel an die Fachkollegen weitergeben als einmal zu wenig.

Alle Karten folgen demselben Schema: Was Du beobachtest — was es bedeuten kann — was hilft — was schadet beziehungsweise wann Du eskalierst.

5.1 ADHS / ADS

Was Du siehst	Was es bedeuten kann	Was hilft	Was schadet / Wann eskalieren
• Hohe motorische Unruhe, häufiges Aufstehen, dauerredet • Wirkt schusselig, vergisst Material, hört scheinbar nicht zu • Reagiert ungesteuert / impulsiv, unterbricht oft • Ermüdet schnell bei monotonen Aufgaben	• Selbststeuerung ist neurobiologisch erschwert • Reizfilter funktioniert anders, Innenleben ist oft laut • Häufig hoher Selbstwertdruck unter der Oberfläche • Möglich: ADS ohne Hyperaktivität — wirkt verträumt	• Klare, kurze Ansagen, Blickkontakt, einen Schritt zur Zeit • Reize reduzieren: stiller Arbeitsplatz, Wackelkissen, Pause • Bewegungsanlässe einbauen — Botengänge, kurze Sprints • Erfolge sofort und konkret rückmelden	• Mehrfach-Aufträge gleichzeitig — überfordert sicher • Vor der Gruppe bloßstellen oder bestrafen • Eskalation an Pädagogische Leitung / Psychologie bei Gefährdung, anhaltender Verweigerung, Schlafproblemen über 3 Tage

5.2 Angststörungen und Schulangst

Was Du siehst	Was es bedeuten kann	Was hilft	Was schadet / Wann eskalieren
• Übelkeit, Bauchweh, Kopfweh — besonders vor Übergängen • Klammern, will nicht allein bleiben • Stille, Rückzug, vermeidet Blickkontakt • Panikartige Reaktionen (Schwitzen, Zittern, Atemnot)	• Vermeidungsverhalten ist Symptom, nicht Trotz • Körpersignale werden katastrophisierend interpretiert • Bindungssystem ist hyperaktiv — Nähe beruhigt • Schulangst hat oft mehrere Ursachen, nicht nur Schule	• Vorhersehbarkeit, Vorausschau („In 10 Min holen wir Dich ab“) • Atemübung anbieten (Box-Atmung), beruhigend mit-atmen • Klein anfangen, kleine Erfolge feiern, nicht überfordern • Symptome ernstnehmen, aber nicht dramatisieren	• Druck, Ironie, „Stell Dich nicht so an“ • Aus Angst „freisprechen“ (alles vermeiden lassen) • Eskalation an Arzt/Psychologie bei Panikattacke, Dissoziation, Suizidäußerungen — immer sofort

5.3 Schulabsentismus

Was Du siehst	Was es bedeuten kann	Was hilft	Was schadet / Wann eskalieren
• Verweigert Klinikschule oder Hausaufgabenzeit • Klagt morgens über	• Angst, Überforderung, Mobbing Erfahrung, depressive Episode	• Enge Absprache mit Klinikschule und Psychologie • Kleine Einheiten,	• Schulvermeidung als bequem werten lassen (Tablet, Spielen)

Was Du siehst	Was es bedeuten kann	Was hilft	Was schadet / Wann eskalieren
Beschwerden, die zur Schulzeit weichen • Versteckt sich, verschläft, erfindet Gründe • Wut, Tränen, Panik bei Schulthemen	• Oft Kombination mit Bindungs- oder Familienthemen • Selten reine Faulheit — fast immer Schutzverhalten • Eltern haben oft eigene Schulängste	Erfolgserebnisse, Anwesenheit vor Leistung • Tagesstruktur halten, auch wenn Schule kurz reduziert wird • Ressourcen sichtbar machen	• Mit Eltern in Frontkonflikt gehen • Eskalation: Bereichsleitung und psychologischer Dienst — Schulabsentismus ist immer Teamthema

5.4 Depressive Episoden / Anpassungsstörungen

Was Du siehst	Was es bedeuten kann	Was hilft	Was schadet / Wann eskalieren
• Antriebsarmut, „keine Lust auf nichts“ • Reizbarkeit, Tränen, sozialer Rückzug • Selbstabwertung („Ich bin doof / nichts wert“) • Schlaf- und Appetitveränderungen	• Depression bei Kindern zeigt sich oft als Reizbarkeit • Suizidale Gedanken sind möglich — auch bei Grundschulkindern • Innere Leere wird häufig als „Langeweile“ beschrieben • Komorbidität mit Angst und ADHS ist häufig	• Verlässliche, geduldige Präsenz — auch im Schweigen • Kleine Aktivierungen, draußen sein, Tageslicht, Bewegung • Positives konkret spiegeln • Selbstwertstärkende Aufgaben	• Aufmunternde Floskeln („Kopf hoch“) • Leistungsdruck oder Vergleiche • Eskalation: bei Selbstabwertung mit Gefährdungshinweis, bei Suizidäußerung — sofort, schriftlich, Übergabe an Psychologie/Arzt

5.5 Somatoforme Störungen

Was Du siehst	Was es bedeuten kann	Was hilft	Was schadet / Wann eskalieren
• Wiederkehrende Schmerzen ohne organische Ursache • Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit, Atemnot situationsabhängig • Symptome verändern sich, wandern • Kind ist sicher, dass es körperlich krank ist	• Körperlicher Ausdruck psychischer Belastung • Kind erfindet nichts — der Schmerz ist real • Aufmerksamkeit auf Symptome verstärkt sie • Familien sind oft erschöpft und verunsichert	• Symptom ernst nehmen, ohne es zu zentrieren • Aktivität anbieten („Probieren wir mal die Schaukel?“) • Gespräche über Symptome zeitlich begrenzen • Erfolge bei Aktivität trotz Symptom benennen	• Symptom ausblenden / leugnen • Symptom durch Sonderrolle belohnen (Hängematte, eigenes Zimmer) • Eskalation an Arzt bei neuen / verändertem Beschwerdebild — Differentialdiagnostik bleibt ärztliche Aufgabe

5.6 Selektiver Mutismus

Was Du siehst	Was es bedeuten kann	Was hilft	Was schadet / Wann eskalieren
• Spricht in der Gruppe nicht, zu Hause / mit Eltern schon • Nickt, zeigt, schreibt — kommuniziert auf Umwegen	• Keine Trotzreaktion, keine Sturheit • Sprechen ist mit Angst gekoppelt — nicht mit	• Druckfrei begegnen, lächeln, dasein • Nonverbale Kommunikation akzeptieren	• Direkte Fragen vor der Gruppe • Sprechen erzwingen oder belohnen mit großer Geste

Was Du siehst	Was es bedeuten kann	Was hilft	Was schadet / Wann eskalieren
• Hohe Anspannung sichtbar im Körper • Hat oft komorbide Ängste	Unwillen • Druck verstärkt das Schweigen • Spontansprechen ist Riesenfortschritt — vorsichtig würdigen	• Schrittweise: Nicken → Flüstern → Einzelwort → Satz • Eng mit Psychologie abstimmen, Verhaltensplan einhalten	• Eskalation bei Verschlechterung oder Schulausschlusserleben — Bereichsleitung und Psychologie

5.7 Autismus-Spektrum-Verdacht

Was Du siehst	Was es bedeuten kann	Was hilft	Was schadet / Wann eskalieren
• Wenig spontaner Blickkontakt • Spezialinteressen, Routinen, sensorische Empfindlichkeit • Übergänge sind besonders schwer • Spricht erwachsen oder ungewöhnlich	• Reizverarbeitung ist anders — nicht falsch • Soziale Regeln müssen oft explizit gelernt werden • Veränderungen lösen Stress aus, nicht Bockigkeit • Diagnostik ist langwierig — Verdacht bleibt Verdacht bis zur Abklärung	• Klarheit, Struktur, Schriftlichkeit / Piktogramme • Reizarmen Rückzugsort anbieten • Übergänge ankündigen, Countdown nutzen • Spezialinteressen wertschätzen, vorsichtig erweitern	• Augenkontakt einfordern • Veränderungen ohne Vorwarnung • Eskalation an Arzt/Psychologie bei deutlichen Anhaltspunkten, Selbstverletzung, sensorischer Überlastung

6. Material und Hilfsmittel — der Methodenkoffer

Der Methodenkoffer ist im Gruppenraum sichtbar geordnet. Er enthält Dinge, die uns im Alltag und besonders in herausfordernden Situationen verlässlich helfen. Jedes Element ist beschriftet, nach jedem Dienst sichten und nachfüllen.

6.1 Selbstregulation und Beruhigung

- Sensorisches Material: Knetkugel, Stachelball, Linsen-Säckchen, Anti-Stress-Würfel.
- Atemkarten: Bildkarten für Box-, Bauch-, 4-7-8-Atmung.
- Gefühle-Plakat (5-12-Jahres-Variante) mit Bildern statt nur Worten.
- Sanduhren in 1 / 3 / 5 Minuten — sichtbare Zeit reduziert Stress.

6.2 Struktur und Übergänge

- Visuelle Tagesplan-Karten (Piktogramme) für die Magnettafel.
- Visualisierter Wochenplan in der Gruppe.
- Jetzt — Gleich — Später-Tafel.
- Countdown-Karten für Übergänge (5/3/1 Minute).

6.3 Beziehung und Sprache

- Erzählwürfel, Gefühlekarten („Wie geht es Dir heute?“).
- Bilderbücher zu Angst, Wut, Trauer, Mut (Kinderpsychiatrie-tauglich, Auswahlliste im Hub).
- Marte-Meo-Spickzettel an der Innenseite der Schranktür.

6.4 Aktivität und Naturraum

- Bewegungsbox: Springseile, Reifen, Sandsäckchen, kleine Bälle.
- Naturbox: Fernglas, Becherlupe, Bestimmungskarten Allgäu.
- Bastel- und Kreativmaterial sortenrein, nachgefüllt.

Faustregel Material

Was nicht beschriftet ist, ist nicht im Koffer.

Was kaputt ist, wird entsorgt — nicht zurückgelegt.

Was sicherheitsrelevant ist (Scheren, Schnüre, Kleinteile), bleibt unter Aufsicht.

7. Eskalations- und Deeskalations-Konzept

Eskalationen sind nicht das Versagen einer Beziehung, sondern Teil unseres Berufs. Entscheidend ist, dass wir vorhersehbar, sicher und würdevoll handeln. Wir orientieren uns am Stufenmodell.

7.1 Das 5-Stufen-Modell

- Stufe 1 — Unruhe: Reizreduktion, Nähe anbieten, Marte-Meo-Benennen.
- Stufe 2 — Ausagieren beginnt: ruhige Stimme, Körperhaltung tief, Atmung verlangsamen, Optionen anbieten (nicht Fragen).
- Stufe 3 — Krise: 1:1-Begleitung, andere Kinder aus der Situation nehmen, Eskalationsteam informieren.
- Stufe 4 — Gefährdung: Schutz aller Beteiligten geht vor Programm. Arzt vom Dienst, ggf. Begleitperson holen.
- Stufe 5 — Nachsorge: Kind nicht allein lassen, kein Wertungsgespräch in der Akutphase. Reflexion erst, wenn Ruhe eingeleitet ist (frühestens 30 Min). Dokumentation.

7.2 Was im Akutfall hilft

- Wenig Worte. Kurze Sätze. „Ich bin da. Ich helfe Dir.“
- Körper unterhalb der Augenhöhe des Kindes — wir machen uns kleiner.
- Sichere Nähe ohne Festhalten, wenn das Kind das zulässt.
- Time-In statt Time-Out: das Kind bleibt mit uns, in einem ruhigen Bereich.

7.3 Was wir nicht tun

- Festhalten ohne akute Gefährdung.
- Schreien, ironisieren, beschämen.
- In der Akutphase Konsequenzen verhängen, Belohnungen entziehen oder mit Eltern drohen.
- Allein in einem Raum einschließen — niemals.

7.4 Nach der Eskalation — Pflichten

- Dokumentation im pädagogischen Tagesbericht innerhalb des Dienstes.
- Übergabe an Folgedienst mündlich plus schriftlich.
- Information Bereichsleitung bei Stufe 3 und höher noch am selben Tag.
- Bei Verletzungsrisiko oder körperlicher Intervention: Vorfallsbericht innerhalb 24 Stunden.

Notfall-Sofortmaßnahmen

Stufe 4 / Gefährdung: Arzt vom Dienst — Tel. wie im Wissens-Hub hinterlegt.

Bei medizinischem Notfall: 112.

Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung: Insoweit erfahrene Fachkraft (IsoFa) noch am selben Tag.

Bei sexualisierter Grenzverletzung: Präventionsbeauftragte des Trägers — Schweige- und Meldepflicht beachten.

8. Institutionelles Schutzkonzept

Als katholischer Träger sind wir der Präventionsordnung der Deutschen Bischofskonferenz und den entsprechenden Diözesanverordnungen verpflichtet. Zusätzlich gelten die staatlichen Schutzaufträge nach § 8a und § 72a SGB VIII sowie das Bundeskinderschutzgesetz. Das vorliegende Kapitel ist die operative Konkretisierung für den pädagogischen Bereich.

8.1 Risikoanalyse

Spezifische Risiken im stationären Setting werden regelmäßig — mindestens jährlich — überprüft. Hochrisiko-Situationen: 1:1-Kontakte ohne Sichtbarkeit, Übergänge zwischen Räumen, Nacht- und Randzeiten, körpernahe Aktivitäten (Schwimmbad, Snoezelen), Toiletten- und Umkleidesituationen.

8.2 Verhaltenskodex — Verbindlich für alle Mitarbeitenden

- Keine 1:1-Situationen hinter geschlossenen, blickdichten Türen ohne Notwendigkeit und Dokumentation.
- Keine privaten Kontakte mit Kindern (Social Media, Telefon, Treffen) während oder nach dem Aufenthalt.
- Keine Geschenke an einzelne Kinder, keine Bevorzugung.
- Körperkontakt ist begrüßenswert, wenn er pädagogisch indiziert ist, vom Kind angenommen wird und für alle sichtbar ist. Kein Kontakt im Intimbereich, kein „auf den Schoß“.
- Fotos und Videos ausschließlich auf Dienstgeräten, mit Einwilligung, für dienstliche Zwecke.
- Eigene Erschöpfung, Überforderung oder Grenzüberschreitung wird offen angesprochen — kollegial oder bei Bereichsleitung.

8.3 Meldewege bei Verdacht

- Schritt 1: Beobachtung sachlich notieren — was, wo, wann, wer, Originaltöne.
- Schritt 2: Keine eigene Befragung des Kindes über das Wahrgenommene hinaus.
- Schritt 3: Sofortige Information an Bereichsleitung und Präventionsbeauftragte.
- Schritt 4: Beratung mit insoweit erfahrener Fachkraft (IsoFa) gemäß § 8a SGB VIII.
- Schritt 5: Risikoeinschätzung im Team, weitere Schritte nach Trägerverfahren.

8.4 Partizipations- und Beschwerderechte der Kinder

Kinder müssen wissen, an wen sie sich wenden können. In jeder Gruppe hängt der Aushang „An wen kann ich mich wenden?“ auf Augenhöhe. Vertrauenspersonen sind benannt. Eine kindgerechte Beschwerdebox ist installiert. Die Klinikseelsorge ist als externe Vertrauensinstanz erreichbar.

8.5 Personalauswahl und Schulung

- Erweitertes Führungszeugnis bei Einstellung und alle 5 Jahre.
- Selbstverpflichtungserklärung zum Verhaltenskodex bei Einstellung.
- Verpflichtende Präventionsschulung im Onboarding (siehe Wissens-Hub).

- Auffrischung mindestens alle 3 Jahre, dokumentiert.

9. Umgang mit abgängigen Kindern

Ein Kind ist abgängig, wenn sein Aufenthaltsort innerhalb der vereinbarten Gruppen-, Tages- oder Klinikgrenzen nicht mehr nachweisbar ist und es nicht innerhalb weniger Minuten gefunden werden kann. Wir handeln entschieden, aber ohne Panik. Jede Minute zählt — und jede Minute hat ein klares Drehbuch.

9.1 Sofortprotokoll — die ersten 15 Minuten

- Minute 0–2: Letzten gesehenen Ort, Uhrzeit, Kleidung dokumentieren. Andere Kinder ruhig zusammenführen.
- Minute 2–5: Naheliegende Räume systematisch absuchen — Toilette, Garderobe, Außenbereich Gruppe, Zimmer des Kindes.
- Minute 5–10: Bereichsleitung informieren. Pforte informieren (Beobachten an Ausgängen). Begleitperson informieren — ruhig, faktisch.
- Minute 10–15: Klinikgelände systematisch absuchen — feste Zuständigkeiten verteilen, Funkkontakt halten.

9.2 Wenn das Kind nach 15 Minuten nicht gefunden ist

- Geschäftsführung / Hausleitung informieren.
- Polizei verständigen (110) — Beschreibung, Foto wenn vorhanden, Hinweise auf Gefährdungssituation.
- Suche auf das umliegende Gelände ausdehnen (skywalk allgäu, umliegende Wege, Bushaltestelle, Bahnhof Scheidegg).
- Lückenlose schriftliche Dokumentation parallel führen.

9.3 Wenn das Kind wieder da ist

- Erste Worte: Erleichterung, nicht Vorwurf. „Schön, dass Du wieder da bist. Ich war besorgt.“
- Medizinische Sichtung — ist das Kind unversehrt?
- Erst nach Beruhigung Klärungsgespräch — warum, wohin, wovor.
- Nachbesprechung im Team: Was war auslösend, was hat geholfen, was muss strukturell geändert werden?

9.4 Prävention

- Risikobeobachtung: Welche Kinder zeigen Fluchttendenzen? — frühe Übergabe im Team.
- Strukturelle Sicherung: Übergaben mit Anwesenheitsliste, Sichtkontrolle an Übergangspunkten.
- Vertrauensgespräche bei Kindern mit Belastungsgeschichte — wir ahnen oft mehr, als wir wissen.

10. Mitarbeiterschutz

Die Arbeit mit psychisch und psychosomatisch belasteten Kindern ist erfüllend und herausfordernd. Sie hinterlässt Spuren. Wir nehmen die Fürsorge für unsere Mitarbeitenden so ernst wie die für die Kinder.

10.1 Selbstfürsorge ist Pflicht, nicht Privatsache

- Pausen werden tatsächlich genommen, nicht in der Gruppe verbracht.
- Schlechte Tage werden im Dienst angesprochen, Übergabe nutzt das.
- Privates Handy bleibt in der Tasche — Präsenz mit den Kindern und Schutz der eigenen Erholungszeit.

10.2 Supervision und kollegiale Beratung

- Externe Supervision im monatlichen Rhythmus (verbindliche Teilnahme).
- Kollegiale Fallbesprechung wöchentlich im Team.
- Anlassbezogene Supervision nach belastenden Vorfällen (Eskalation Stufe 4+, Abgängigkeit, Tod oder schwere Krankheit eines Kindes).

10.3 Sekundäre Traumatisierung — Warnzeichen

- Schlafstörungen, Alpträume, kreisende Gedanken um Kinder im Privaten.
- Reizbarkeit, Zynismus, Abstumpfung.
- Vermeidung bestimmter Themen oder Kinder.
- Bei Anzeichen: Bereichsleitung ansprechen, Mitarbeiterberatung in Anspruch nehmen, ärztliche Abklärung wenn nötig.

10.4 Grenzen und Beschwerderecht der Mitarbeitenden

- Wer übergriffiges Verhalten von Kindern, Eltern oder Kolleg:innen erlebt, hat das Recht und die Pflicht, dies zu melden.
- Anlaufstellen: Bereichsleitung, Mitarbeitervertretung, Beschwerdestelle des Trägers.

11. Elternarbeit — die Schnittstelle

Elternarbeit im engeren Sinn — Schulung, Beratung, Therapie der Begleitperson — wird von Psychologie, Sozialdienst und Ärzten verantwortet. Unsere Aufgabe als Erzieher ist die Schnittstelle: die tägliche Übergabe, das kurze Tür-und-Angel-Gespräch, die niedrigschwellige Information.

11.1 Was wir leisten

- Tägliche Übergabe morgens und mittags — kurz, faktisch, ressourcenorientiert.
- Information über besondere Vorkommnisse zeitnah und sachlich.
- Wertschätzende Begegnung — die Begleitperson ist selbst Patient und oft erschöpft.
- Weiterleiten an die zuständige Berufsgruppe, wenn Fragen über unsere Rolle hinausgehen.

11.2 Was wir nicht leisten

- Therapeutische Gespräche oder Beratungen.
- Diagnostische Einschätzungen oder Empfehlungen zu Medikation.
- Vermittlung zwischen getrennt lebenden Eltern oder rechtliche Fragen.
- Vertrauliche Aussagen des Kindes ohne dessen Wissen weitergeben — Ausnahme: Gefährdungslagen.

11.3 Kommunikationsstandards

- Begrüßung mit Namen, Augenhöhe, kurzer Smalltalk vor sachlicher Information.
- Bei Konflikten: zuhören, spiegeln, nicht rechtfertigen, an Bereichsleitung weiterleiten.
- Schriftliches gehört in den Dokumentationsbogen, nicht in WhatsApp oder Privatmail.

12. Schnittstellen im multiprofessionellen Team

Erzieher, Medizin, Psychologie, Therapie und Klinikschule arbeiten gemeinsam für ein Reha-Ziel. Klare Zuständigkeiten verhindern Reibung und Doppelarbeit.

12.1 Wer ist wofür zuständig?

- Medizin: Diagnose, Medikation, körperliche Akutfälle, gesundheitliche Gesamtbeurteilung.
- Psychologie: Psychotherapie, Diagnostik, Krisenintervention bei psychischer Gefährdung, Verhaltenspläne.
- Therapie (Physio, Ergo, Logo, Kunst, Bewegung): therapeutische Einheiten und deren Transfer.
- Klinikschule: Schulischer Anschluss, Lerndiagnostik, Lernförderung, Klassenkontakt.
- Erzieher / Pädagogik: Alltagsbegleitung, Gruppendynamik, Beziehung, Transfer der Therapie in den Alltag, Selbstwirksamkeit.

12.2 Wie wir kommunizieren

- Tägliche schriftliche Übergabe im KIS / Dokumentationssystem.
- Wöchentliche Fallbesprechung interdisziplinär.
- Bei akuten Themen: Telefon — nicht E-Mail.
- Pädagogische Beobachtungen sind wertvoll für die Diagnostik — wir berichten sachlich und ohne Bewertung.

12.3 Eskalationskette intern

- Standard: Übergabe an Folgedienst.
- Auffälligkeit: Bereichsleitung im selben Dienst.
- Akute Krise: Arzt vom Dienst und Psychologie parallel.
- Verdacht Kindeswohlgefährdung: Präventionsbeauftragte und IsoFa noch am selben Tag.

13. Rechtliche Grundlagen und Referenzen

Dieses Konzept basiert auf den folgenden gesetzlichen und fachlichen Grundlagen. Vollständige Texte sind im Wissens-Hub verlinkt.

13.1 Gesetzliche Grundlagen

- SGB V, SGB VI, SGB IX — Rehabilitation und Teilhabe.
- SGB VIII — Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere § 8a (Schutzauftrag) und § 72a (Tätigkeitsausschluss).
- Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG).
- UN-Kinderrechtskonvention, insbesondere Art. 3 (Kindeswohl), 12 (Beteiligung), 19 (Schutz vor Gewalt).
- Infektionsschutzgesetz (IfSG) — Hygiene und Meldepflichten.
- DSGVO und BDSG — Datenschutz.
- Arbeitsschutzgesetz und JArbSchG — auch für Auszubildende und FSJ.

13.2 Trägerspezifische Grundlagen

- Leitbild der KJF Augsburg.
- Präventionsordnung der Deutschen Bischofskonferenz.
- Präventions- und Schutzkonzept der Diözese Augsburg.

13.3 Fachliche Standards und Leitlinien

- AWMF-S3-Leitlinien zu ADHS, Angststörungen, depressiven Störungen, ASS, Schulabsentismus.
- Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (DGKJP).
- Marte Meo nach Maria Aarts — internationaler Methodenstandard.
- Trauma-informierte Pädagogik (Bruce Perry — Neurosequential Model).
- QMS-Reha BAR und ISO 9001 — Qualitätsmanagement.

14. Anhang

14.1 Onboarding-Checkliste 30 / 60 / 90 Tage

Erste Woche

- Begrüßung durch Bereichsleitung, Hausführung, Vorstellung Team.
- Verhaltenskodex und Selbstverpflichtungserklärung unterschrieben.
- Erweitertes Führungszeugnis vorgelegt.
- Zugang zu Wissens-Hub, KIS, Dokumentation eingerichtet.
- Buddy zugewiesen — feste Bezugsperson für die ersten 90 Tage.

30 Tage

- Pflicht-Schulung Präventionsordnung absolviert und dokumentiert.
- Eskalations- und Notfallprotokolle gekannt und kurz abgefragt.
- Erste Diagnose-Module im Wissens-Hub durchgearbeitet (ADHS, Angst, Schulabsentismus).
- Erste Hospitation in allen Dienstphasen abgeschlossen (früh, mittag, spät).
- Erstes Reflexionsgespräch mit Bereichsleitung.

60 Tage

- Marte-Meo-Grundlagen-Modul abgeschlossen.
- Eigenständige Gruppenleitung in einfachen Settings.
- Erste Fallbesprechung aktiv mitgestaltet.
- Feedback an Bereichsleitung — was war hilfreich, was fehlt?

90 Tage

- Alle Diagnose-Module im Wissens-Hub bearbeitet.
- Eigenständige Dokumentation und Übergabe sicher.
- Probezeit-Gespräch mit Bereichsleitung.
- Bilanz und Entwicklungsplan für das erste Jahr.

14.2 Notfall-Telefonliste (Platzhalter)

- Arzt vom Dienst: < intern hinterlegen >
- Bereichsleitung Pädagogik: < intern hinterlegen >
- Präventionsbeauftragte: < intern hinterlegen >
- Insoweit erfahrene Fachkraft (IsoFa): < intern hinterlegen >
- Polizei: 110 · Rettungsdienst: 112
- Klinikseelsorge: < intern hinterlegen >
- Mitarbeiterberatung / EAP: < intern hinterlegen >

14.3 Glossar (Auswahl)

- Co-Regulation — Regulation der kindlichen Anspannung über die Anwesenheit eines ruhigen Erwachsenen.
- IsoFa — Insoweit erfahrene Fachkraft gemäß § 8a SGB VIII, externe Beratung im Verdachtsfall.
- Komorbidität — gleichzeitiges Auftreten mehrerer Diagnosen.
- Marte Meo — videogestützte Methode zur Förderung gelingender Beziehung, Maria Aarts.
- Mutismus, selektiv — Sprechhemmung in bestimmten Situationen bei sonst intakter Sprache.
- Psychosomatik — körperliche Symptome mit relevantem psychischen Anteil.
- Trauma-informiert — Haltung, die Verhalten als möglichen Ausdruck früherer Belastung versteht.

14.4 Versions- und Freigabevermerk

Version 1.0 · Freigabe Mai 2026 · Pädagogische Bereichsleitung · Nächster Review: Mai 2027 oder anlassbezogen früher. Inhaltliche Verantwortung: Pädagogische Bereichsleitung. QM-Verantwortung: QM-Beauftragte der Fachklinik. Verteilung: digital im Wissens-Hub, gedruckt im Dienstzimmer.

— Ende des Dokuments —